

PACIENTE PSICÓTICO EN URGENCIAS

S. Nuñez Sevillano, C.M. Franch Pato, V. Ámez Cepeda, R. Gómez Martínez.

-Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —**Miguel de Cervantes**. Don Quijote de la Mancha.

La psicosis es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida significativa del contacto entre la realidad objetiva (externa y racional) del paciente y sus correspondientes representaciones mentales. Los componentes principales de la psicosis son los delirios, las alucinaciones y trastornos en la forma del pensamiento y de la conducta.

En este capítulo se pretende describir un protocolo de estudio y actuación frente al paciente con sintomatología psicótica que pueda acudir al Servicio de Urgencias.

SEMIOLOGÍA DE LA PSICOSIS

Los síntomas más característicos de la psicosis son los siguientes:

Los **delirios** se describen como alteraciones del contenido del pensamiento que deben cumplir las siguientes características:

- Son erróneas.
- Se mantienen irrefutables ante cualquier argumentación basada en la lógica.
- Se establecen por una vía patológica.
- Se consideran primarias, puesto que no dependen de otra alteración psicopatológica, en este caso se trataría de ideas deliroides.

El contenido más habitual del pensamiento en pacientes con esquizofrenia **suele ser de tipo persecutorio**, que suele mostrarse en forma de elevada suspicacia, aunque en ocasiones pueden apreciarse tintes megalomaniacos. La vivencia de estos pensamientos suele acompañarse de angustia intensa que puede ocasionar, incluso, bloqueos del pensamiento.

Las **alucinaciones** son otra manifestación clínica principal de la clínica psicótica. Se definen como alteraciones de la sensopercepción en las que no hay objeto real ni estímulo alguno en el mundo exterior. Deben cumplir las siguientes características:

- No dependen de la voluntad del paciente que las padece.
- Son escasamente o nada modificables por la sugestión.
- El paciente se encuentra en un estado de realidad alterado.

En cuanto a los tipos de alucinaciones, podemos encontrar alteraciones de cualquiera de los sentidos. Mientras que en los pacientes con esquizofrenia **es habitual que se presenten alucinaciones auditivas**, en forma de voces, ruidos o susurros, con gran repercusión afectiva por las mismas, las alucinaciones visuales son infinitamente menos frecuentes en pacientes con esta patología. La presencia de **alucinaciones visuales debe hacernos sospechar hacia un posible origen orgánico** del cuadro, por lo que debemos iniciar un despistaje y valorar consumo de tóxicos.

MOTIVOS DE CONSULTA

El paciente puede ser derivado al Servicio de Urgencias ya sea **de forma voluntaria**, por el

propio malestar que le generan los síntomas de su padecimiento, **o de forma involuntaria** a través de la solicitud de los familiares o el médico de área para valoración por los especialistas.

Los **motivos pueden variar** desde la clínica primordial de su enfermedad, como las alteraciones descritas en el apartado anterior, a alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de los ritmos biológicos, inhibición psicomotriz, heteroagresividad, tentativas autolíticas o efectos secundarios de la medicación.

SÍNTOMAS ATRIBUIBLES A PSICOFÁRMACOS

Dentro de los posibles motivos de consulta del paciente psicótico, se encuentran efectos secundarios de la medicación como:

- **Acatisia:** se define como una inquietud interna que se expresa como la incapacidad para poder estar sentado, tumbado, o quieto. La angustia que provoca esta sintomatología puede provocar alteraciones conductuales. Está indicado disminuir la dosis de antipsicótico, si fuera posible, o el tratamiento sintomático basado en benzodiacepinas o betabloqueantes.
- **Distonías agudas:** se describen como alteraciones musculares en forma de contracción breve y sostenida que provoca posturas anormales en el paciente con repercusión y molestia para el mismo. Está indicado el uso de anticolinérgicos (5mg de biperideno) o benzodiacepinas (5-10mg de diacepam).
- **Parkinsonismo iatrogénico:** se caracteriza por bradicinesia, hipomimia, rigidez o sialorrea, evocando en su presentación a la Enfermedad de Parkinson. Está indicado disminuir la dosis o sustituir por otro antipsicótico menos incisivo, incluso puede coadyuvarse un tratamiento corrector anticolinérgico (biperideno).
- **Discinesias tardías:** se define como un cuadro motor que puede acontecer en pacientes con tratamientos crónicos de neurolépticos, especialmente clásicos y a dosis altas, caracterizado por movimientos anormales involuntarios. Habitualmente empeora tras la retirada brusca de la medicación y aumenta de intensidad tras el uso de fármacos anticolinérgicos.
- **Síndrome neuroléptico maligno:** se trata de una urgencia médica donde la vida del paciente está comprometida, con una mortalidad del 5% en la actualidad. Se caracteriza por **fluctuaciones / alteración del nivel de conciencia, rigidez muscular, hipertermia y alteración del sistema nervioso autónomo**, con una importante disfunción autonómica en forma de sudoración (diaforesis), taquipnea, taquicardia e inestabilidad de la tensión arterial. El cuadro suele ir acompañado de rabdomiólisis y leucocitosis, por lo que puede objetivarse un aumento de la CK en la bioquímica. Se trata de un cuadro que suele manejarse en unidades de cuidados intensivos y su manejo se basa en la suspensión del tratamiento (fármacos antagonistas de los receptores de dopamina) y la rápida instauración de hidratación y vigilancia de constantes vitales. El uso de relajantes musculares como el dantrolene o la bromocriptina está indicado en estas situaciones.

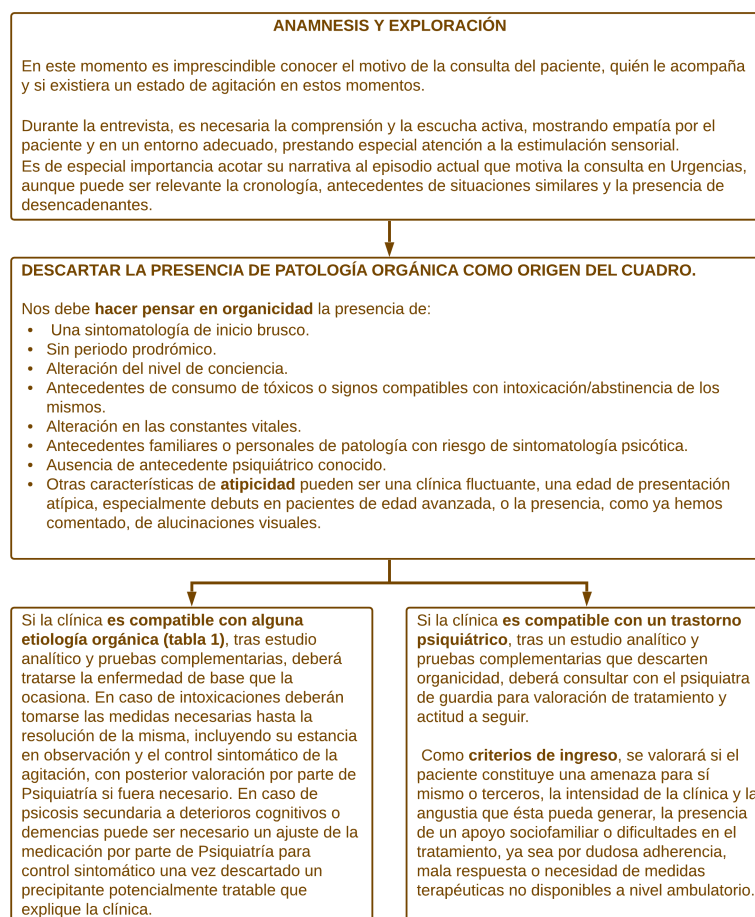


Tabla 1. Trastornos orgánicos en el diagnóstico diferencial de psicosis aguda

- **Abuso de drogas:** alucinógenos, psicoestimulantes, cannabis y sus reacciones de angustia, alcohol con posible alucinosis o abstinencia a sustancias hipnóticas o sedantes.
- **Fármacos y sustancias tóxicas:** anticolinérgicos (en forma de fármacos, plantas o setas), glucocorticoides, toxicidad digital, agonistas dopaminérgicos (tratamiento en Parkinson), isoniacina, metales pesados o disulfuro carbónico.
- **Desequilibrios metabólicos:** hipoglucemias, encefalopatía hepática, porfiria aguda intermitente, Síndrome de Cushing, alteraciones del calcio o de la función tiroidea, pancreatitis o síndromes paraneoplásicos.
- **Deficiencias nutricionales:** insuficiencia de tiamina (vitamina B1) en el Síndrome de Wernicke-Korsakoff, insuficiencia de niacina (vitamina B3) en la pelagra o insuficiencia de vitamina B12.
- **Patología neurológica:** como las encefalitis, los abscesos cerebrales, las meningitis, la neurosífilis, el lupus, enfermedades como la de Wilson, Huntington o Alzheimer, sin olvidar la enfermedad cerebral vascular y las crisis epilépticas parciales complejas.

RESUMEN

- Realizar una anamnesis y exploración en un ambiente tranquilo y con escasa estimulación sensorial.
- Realizar un despistaje de probables causas orgánicas no solo a nivel analítico y de imagen, sino a través de sus antecedentes personales y familiares. Debemos recordar que una analítica de urgencia no descarta patología aguda.
- Prestar atención a signos de atipicidad a la hora de sospechar un origen psiquiátrico.
- Mantener en observación al paciente intoxicado hasta que la clínica propia del tóxico permita llevar a cabo una exploración psicopatológica, si fuera necesaria.

BIBLIOGRAFÍA

- Chinchilla A. Manual de Urgencias Psiquiátricas. Barcelona: Masson, 2003. p. 217-228. 581-585.
- Gastó C, Vallejo J. Manual de diagnóstico diferencial y tratamiento en Psiquiatría. Barcelona: Masson, 2001
- Kaplan HL, Sadock BJ. Manual de Psiquiatría de Urgencias. Madrid: Médica Panamericana, 1996